核心精讲

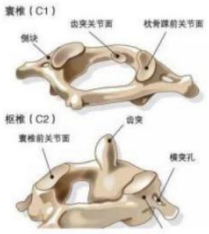
颈腰椎退行性病

性感认识：该章节以讲义为主

一、概述

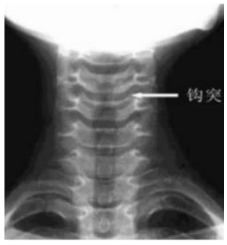
外科　颈腰椎退行性病（含损伤平面判断）
00:00:45--00:11:39

①颈椎1、2无椎间盘，颈椎3-7有钩椎/Luschka关节





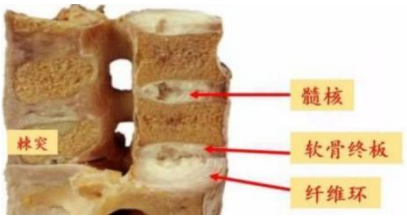


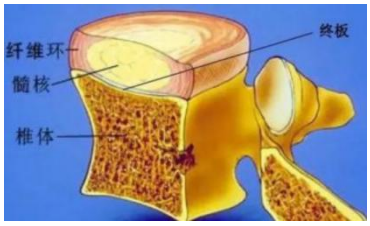


「理顺知识点」

- 第1颈椎又名寰椎，第2颈椎又名枢椎
- 寰枢关节由枢椎的齿突与寰椎前弓后方的关节面构成，寰椎与枢椎间无椎间盘，依靠寰枢关节连接
- 钩椎/Luschka 关节：是颈椎的结构（3-7才有）

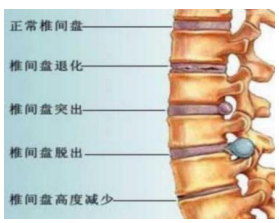
②椎间盘结构：软骨终板、髓核、纤维环

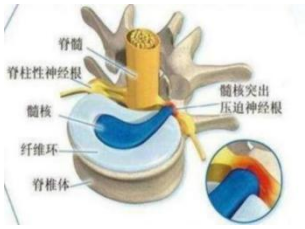


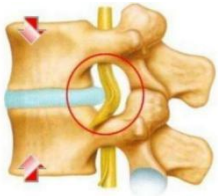


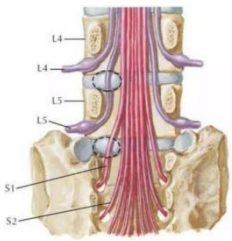
③椎间盘易向侧后方突出，第m-n椎间盘压迫第n神经根

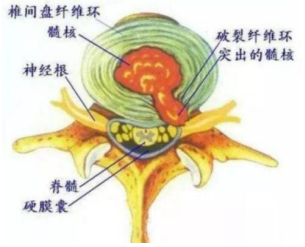
刺激或压迫神经根致疼痛：机械性压迫、化学性刺激、自身免疫性

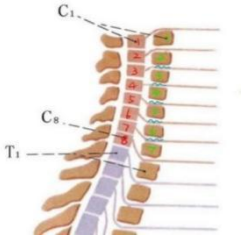












「理顺知识点」

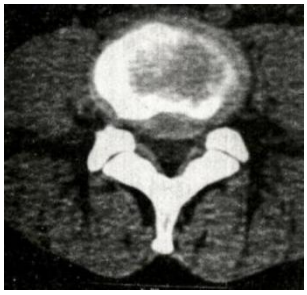
- 椎间盘退变→椎间盘突出、脱出
  →椎间盘变扁→椎间隙狭窄→锥体之间直接接触（硬碰硬）→出现骨质增生

「串联」

- 原发性骨关节炎为关节软骨退变：软骨下骨硬化和囊变、非对称关节间隙/椎间隙狭窄、边缘骨质增生形成骨赘（硬碰硬）

④影像

X线	生理曲度异常、骨质增生、钙化、椎间隙狭窄、椎间盘突出间隙不等宽等。X线不能观察椎间盘
CT	上述X线内容+观察椎间盘，但不能清楚观察神经和脊髓等受压情况
MRI	上述CT内容，清楚观察神经和脊髓等受压情况



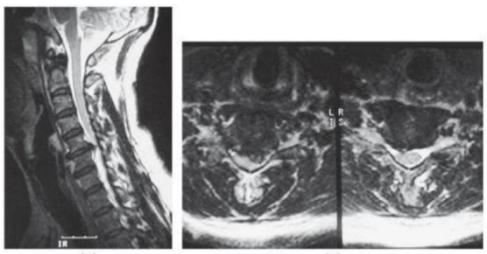


图 69-4　颈 5～颈 6 椎间盘突出
从矢状位（1）及横轴位（2）MRI 上可以看到椎间盘突出压迫硬膜囊及脊髓。

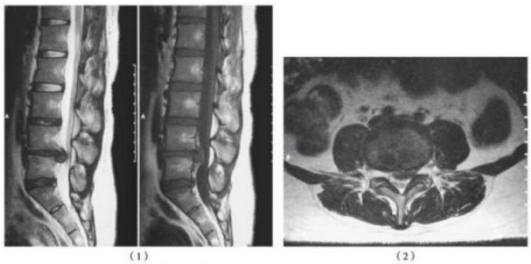


图 69-10　腰 4～腰 5 椎间盘突出的 MRI
矢状位（1）及横轴位（2）MRI 示腰 4～腰 5 较大的椎间盘突出，压迫硬膜囊。

二、颈椎病

外科　颈腰椎退行性病（含损伤平面判断）
00:11:39--00:31:08

1.C_{5-6}好发，女性多见（脖子女性多见如甲状腺疾病、我的脖子好6）

2.类型

	表现	治疗
神经根（最常见）	颈肩痛+上肢放射痛，上肢感觉障碍（麻木）、运动障碍（无力） Eaton征、Spurling征（eason）	首选保守 按摩、颌枕带牵引等
脊髓型（最严重）	持物不稳、踩棉花感，四肢感觉、运动障碍，二便障碍 Hoffmann征、Babinski征（飘、可硬瘫、范围广、哈巴儿）	急诊手术 禁止按摩、颌枕带牵引
交感神经型	交感神经兴奋（心悸、出汗）或抑制的表现（心动过缓、血压↓） 症状多、体征少	首选保守
椎动脉型	猝倒、眩晕、视物模糊	首选保守
食管型	吞咽困难	首选保守





图 69-1　臂丛神经牵拉试验（Eaton 试验）



图 69-2　压头试验（Spurling 征）

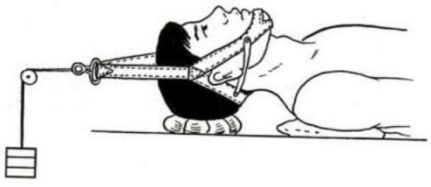
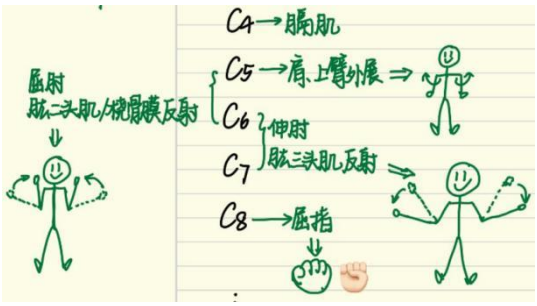


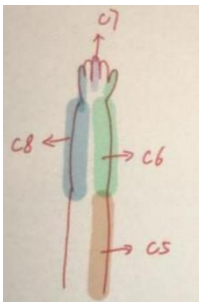
图 58-26　枕颌带牵引

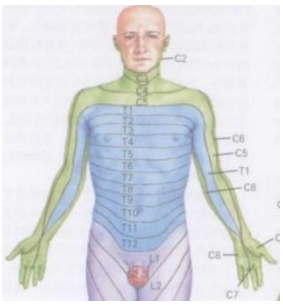
「理顺知识点」

- 椎间盘易向侧后方突出→神经根型颈椎病最常见
- Eaton 试验、Spurling 征/压头试验都可诱发神经根受压症状，可判断神经根受压情况
- 脊髓受累→硬瘫→病理征阳性：Hoffmann征（上肢）、Babinski征（下肢）
- 交感神经兴奋：大失血、低血糖、倾倒综合征、甲亢、嗜铬细胞瘤
- 症征不符：十二指肠 23 部损伤、急性肠系膜上动脉血栓形成或栓塞、胆道蛔虫、交感神经型颈椎病、腰椎管狭窄
- 椎动脉型颈椎病：椎动脉受压→椎-基底动脉供血不全→猝倒、眩晕、视物模糊→若体位改变→对椎动脉的压迫解除→恢复

3.损伤平面判断

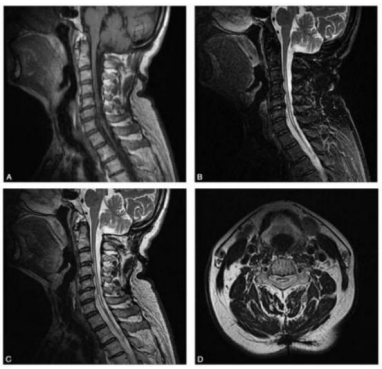


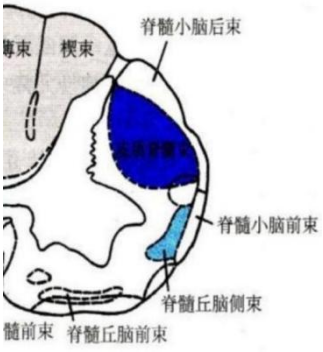




4.鉴别诊断

颈椎病	鉴别	
神经根型	胸廓出口综合征、周围神经卡压综合征	
脊髓型	脊髓空洞症 肌萎缩侧索硬化/渐冻症	脊髓空洞症：感觉分离——痛温觉消失、而触觉及深感觉存在（心已空不知冷暖）
交感神经、椎动脉型	美尼尔病（感动你）	美尼尔病：反复发作听力下降、旋转性眩晕





「理顺知识点」

- 胸廓出口综合征：出口窄会压迫臂丛神经根和锁骨下A
  - 肺上沟瘤：卡压到臂丛神经根，会有肩膀、上肢的感觉运动障碍
- 脊髓空洞症：感觉分离vs.脊髓中央管周围综合征：没有感觉分离（急性期）

三、腰椎间盘突出症

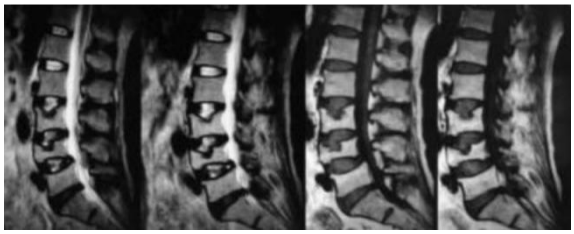
外科　颈腰椎退行性病（含损伤平面判断）
00:31:08--01:20:20

1.L_{4-5}、L_5–S_1好发，男性多见（腰男性多见如肾小球肾炎、我的腰）

2.类型

膨出型	纤维环部分破裂、但表层完整
突出型	纤维环完全破裂、髓核突向椎管，后纵韧带完整
脱出型	髓核突破后纵韧带、髓核根部在椎间隙内
游离型	髓核与原椎间盘完全脱离
许莫氏Schmorl结节	髓核经上下软骨终板的裂隙突入椎体内
经骨突出型	髓核沿软骨终板和椎体之间的血管通道向前纵韧带突出





3.临床表现和治疗

①腰痛（窦椎神经）+下肢放射痛（坐骨神经），腰部活动受限尤其前屈，腰椎侧凸（内奸外患）

「串联」

- 非结构性脊柱侧凸：神经根受刺激（腰椎间盘突出）、癔症、髋关节挛缩、姿势不当、下肢不等长、炎症「神医说知无不言」
- 髓核突出在神经根的内侧，腰椎凸向健侧，弯向患侧
- 髓核突出在神经根的外侧，腰椎凸向患侧，弯向健侧「内奸外患」

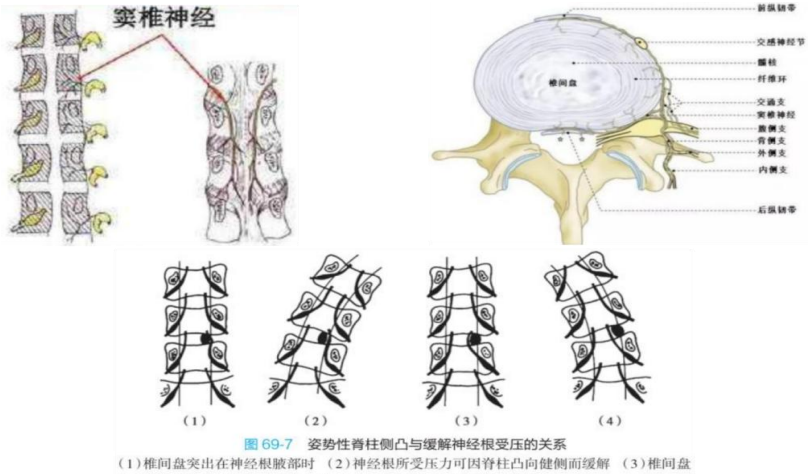
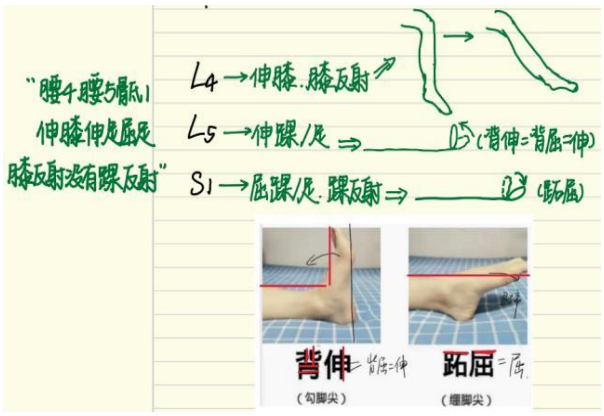
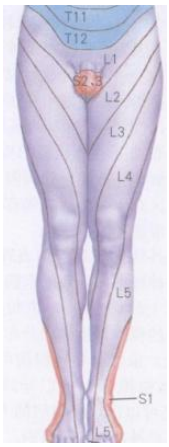


图 69-7　姿势性脊柱侧凸与缓解神经根受压的关系
（1）椎间盘突出在神经根脓部时　（2）神经根所受压力可因脊柱凸向健侧而缓解　（3）椎间盘突出在神经根外侧时　（4）神经根所受压力可因脊柱凸向患侧而缓解

②损伤平面判断（$L_4L_5S_1$伸膝伸足屈足、膝反射没有踝反射、4-股四头肌-伸膝、自己摸）

神经根	对应神经	运动障碍	感觉障碍	深反射障碍
L_4（L_{3-4}椎间盘）	股神经	伸膝	膝前、小腿前内、内踝	膝反射
L_5（L_{4-5}椎间盘）	腓总神经	伸踝、伸足	小腿外前、足背内	
S_1（L_5-S_1椎间盘）	胫神经	屈踝、屈足	小腿后、足外、外踝	踝/跟腱反射







「理顺知识点」

- 记忆思路：
  - L_4：联想到股四头肌（参与膝跳反射），股四头肌位于大腿前（摸的起点），从起点往内摸：膝前→小腿前内→内踝
  - L_5：起点在小腿外前，从起点往内摸：小腿外前→足背内
  - S_1：起点在小腿后，从起点往内摸：小腿后→足外、外踝

③膨出型、Schmorl结节、经骨突出型：无神经根受压→直腿抬高(-)及加强(-)，保守治疗

（紧箍不许摸不许碰）

④突出型、脱出型、游离型：有神经根受压→直腿抬高(+)/Lasegue征及加强(+)，保守治疗→无效手术。

但二便障碍（马尾神经受压）急诊手术（注意：只是鞍区感觉异常不用急诊手术）

「理顺知识点」

- 马尾神经受压后可有鞍区感觉异常和括约肌功能障碍，但若仅出现鞍区感觉异常，括约肌功能尚可，则不用急诊手术

4.鉴别诊断

（1）直腿抬高(+)及加强试验(-)：急性腰扭伤、梨状肌综合征（急粒来不及加强）

（2）直腿抬高(-)及加强试验(-)：

①腰椎间盘膨出型、Schmorl结节、经骨突出型

②慢性腰肌劳损

③第三腰椎横突综合征

④腰椎管狭窄：症状多、体征少，神经源性间歇性跛行

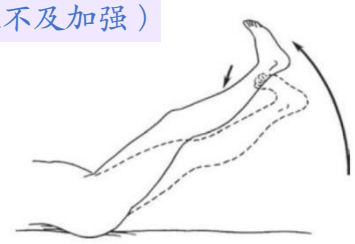


图 69-8　直腿抬高试验(实线)和加强试验(虚线)

	腰痛（窦椎神经）	下肢放射痛 「你下盘」	直腿抬高	加强
腰椎间盘膨出	√	×	−	−
腰椎间盘突出	√最早	√	+	+
急性腰扭伤	√	×	+假阳	−
梨状肌综合征	×	√	+	−
腰肌劳损	√	×	−	−
第三腰椎横突综合征	√	×	−	−
腰椎管狭窄	√	√	−	−

症征不符：十二指肠23部损伤、交感神经型颈椎病、胆道蛔虫、腰椎管狭窄、急性肠系膜上动脉血栓形成或栓塞（123交警逮到要赔偿）

真题解析·颈腰椎退行性病

外科　颈腰椎退行性病（含损伤平面判断）
01:20:20--01:36:20

1.2013N90A颈椎病中发病率最高的类型是

A.脊髓型

B.神经根型

C.椎动脉型

D.交感型

2.2013N179X腰椎间盘突出症骶1神经根受压时的临床表现有

A.外踝附近及足外侧痛、感觉减弱

B.踝及伸拇肌力减弱

C.踝反射减弱或消失

D.直腿抬高试验及加强试验(+)

3.2014N89A脊髓型颈椎病早期出现的症状是

A.四肢乏力，持物不稳

B.颈肩痛向上肢放射　神经根型颈椎病

C.头痛、心悸　交感神经型颈椎病

D.眩晕　椎动脉型颈椎病

　答案：1−3 B ACD A

4.2015N180X腰椎间盘突出致使坐骨神经痛的原因有

A.破裂的椎间盘组织产生化学物质的刺激

B.纤维环内层受到突出的髓核刺激

C.自身免疫反应使神经根发生炎症

D.受压的神经根缺血

5.2016N90A女性，52岁，颈部痛伴右肩部痛一年余，近五个月出现四肢麻木，无力，行走时有踩棉花样感，查体：颈椎无明显畸形，活动轻度受限，右手及前臂尺侧感觉减退，双下肢肌张力增高，肌力Ⅳ级，X线示颈椎骨质增生，生理曲度变直。最可能的诊断是

A.交感神经型颈椎病

B.肩周炎

C.脊髓型颈椎病

D.颈椎肿瘤

6.2017N67A下列关于颈椎病的叙述中，不正确的是

A.可有心动过速等交感神经表现

B.神经根型表现为手部麻木无力

C.骨赘压迫食管可引起吞咽困难

D.交感型颈椎病最多见

7.2018N67A患者腰椎间盘突出，若髓核突出在神经根的外侧时，减轻疼痛的姿势性代偿变化是

A.腰椎凸向健侧

B.腰椎凸向患侧

内奸外患

C.腰椎无侧凸变化

D.腰椎前凸消失

8.2019N103-105A男性，55岁。腰痛3个月，查体：L4、L5水平棘突间压痛。双下肢无畸形，肌力正常，双侧膝反射正常，跟腱反射未引出；双下肢肢体深浅感觉对称、正常，鞍区痛、触觉减退。

103.为明确诊断，应首选的检查是

A.X线片

B.MRI

C.肌电图

D.脊髓造影

　答案：4-8 ACD C D B BCA

104.本病与腰椎管狭窄进行鉴别诊断的要点是

A.下腰痛

B.持续跛行

C.症状多、阳性体征少

D.鞍区感觉异常

105.首选的治疗方法是

A.非手术治疗

B.椎板切除减压术

C.微创髓核摘除术

D.椎板减压加椎弓根钉内固定术

9.2021N66A单纯腰椎间盘突出症行经皮腰椎间盘切除术的适应证是

A.膨出型

B.脱出型

C.经骨突出型

D.Schmorl结节

10.2021N164X属于椎间盘结构的有

A.髓核

B.软骨终板

C.前纵韧带

D.纤维环

11.2022N65A腰椎管狭窄症区别于腰椎间盘突出症的主要临床特点是

A.腰痛

B.坐骨神经痛

C.腰椎侧凸

D.神经源性间歇跛行

　答案：9-11 B ABD D

12.2023N103-105A男性，54岁。右颈肩痛2年伴右手麻木3个月，颈部活动受限1周。查体：C_{5-6}棘突间压痛，右手掌桡侧皮肤感觉减退，Eaton试验(+)，Spurling征(+)。X线片显示颈椎生理弧度消失，C_{5-6}椎体后缘骨质增生。初步诊断为颈椎病。

103.下列选项中，最有诊断价值的是

A.颈肩部疼痛

B.颈部活动受限

C.右手麻木

D.Eaton试验(+)

104.最需要鉴别的疾病是

A.脊髓空洞症

B.胸廓出口综合征

C.肌萎缩侧索硬化症

D.肩周炎

105.该患者MRI检查显示颈椎间盘突出，脊髓与神经根受压。目前不推荐的治疗是

A.颈椎牵引

B.颈部按摩和推拿

C.手术治疗

D.应用非甾体抗炎药

13.2024N67A男性，40岁。腰扭伤后反复腰痛2年，右下肢放射痛2个月，与劳累有关，咳嗽、用力排便时可加重。骨科检查：右直腿抬高试验阳性，加强试验阳性。X线片示L_{4-5}椎间隙变窄。最可能的诊断是

A.急性腰扭伤

B.梨状肌综合征

C.腰椎管狭窄症

D.腰椎间盘突出症

14.2024N164X脊髓型颈椎病可能的临床表现有

A.双足踩棉花感

B.双上肢麻木无力，浅反射减弱或消失

C.二便功能障碍

D.双下肢麻木无力，腱反射活跃或亢进

高位中枢平时易化浅反射，抑制深反射
出现硬瘫时，浅反射↓，深反射↑

　答案：12-14 DBB D ABCD

15.2025N164X神经根型颈椎病和肩周炎可能的相同临床表现有

A.肩痛

B.肩关节活动受限

C.手痛

D.上臂痛

　答案：15 ABD